

16 - 04-Les manifestations cutanées du VIH - Pr. Amal

Le cours d'aujourd'hui est intitulé « Les manifestations cutanées de VIH ». Les manifestations cutanées de VIH sont possibles quel que soit le stade de l'infection, c'est-à-dire au début de l'infection, lors de la primo-infection, au stade de portage asymptomatique ou au stade de sida maladie. Ces manifestations sont fréquentes, polymorphes et parfois révélatrices de l'infection, le cas par exemple du zona chez un sujet jeune. Certaines de ces infections sont des marqueurs pronostiques témoignant d'une défaillance immunitaire importante, le cas par exemple de la leucoplasie chevelue de la langue ou de la maladie de Kaposi.

Ces manifestations cutanées ont une évolution chronique, prolongée, révèle au traitement. Les objectifs de ce cours, c'est de décrire les manifestations cutanées de la primo-infection par le VIH, diagnostiquer la maladie de Kaposi, identifier les différentes infections cutanées rencontrées au cours de l'infection par le VIH, identifier les manifestations cutanées non infectieuses de l'infection par le VIH et énumérer les manifestations dermatologiques devant faire proposer une sérologie. Ces manifestations cutanées sont classées en manifestations cutanées de la primo-infection et les manifestations cutanées secondaires aux dysfonctionnements immunitaires, donc la pathologie cimmorale, la pathologie infectieuse et les manifestations cutanées non infectieuses non cimmorales.

On va commencer par la primo-infection. La période d'incubation est aux alentours de deux à trois semaines, donc après un contact avec le virus, le VIH, soit après un rapport sexuel non protégé, soit après un accident d'exposition au sang, soit suite à des injections par des seringues infectées. Il y a l'apparition des signes généraux.

Vous avez un tableau de fièvre, 38-39 degrés, sueur, asthénie, des céphalées, des douleurs pharyngées, des signes digestifs, des polyadénopathies, des signes neurologiques, type de syndrome mélangé, trouble du comportement, oncéphalite, crise convulsive, polyradiculonevrite. Sur le plan cutané, on a une éruption cutanée qui n'est pas constante. On ne voit pas chez tous les malades, c'est aux alentours de 60 à 70 % des cas.

Ça donne un érythème morbidiforme, c'est-à-dire un érythème généralisé avec des intervalles de peau saine. Ça touche le tronc, la racine des membres, le cou, le visage. En général, c'est des petites lésions, des maculopapilles de quelques millimètres à un centimètre de diamètre morbidiformes, c'est-à-dire avec des intervalles de peau saine.

Les poignées et les plantes du pied ne sont pas respectées, donc elles peuvent être atteintes. Même dans certaines formes, on a une atteinte isolée des poignées et des plantes. Le prurite est inconstant.

La durée d'évolution de cette primo-infection est entre 5 à 10 jours. Certaines formes atypiques ont été décrites, des lésions type dursicaires, des éruptions vésiculopistuleuses ou bien une

éruption palmoplantaire isolée. Donc on voit ici des lésions érythémateuses morbidiformes, un érythème morbidiforme avec des lésions des macules érythémateuses et avec des intervalles de peau saine.

Et vous y trouvez des maculopapules, on a des papules et des macules morbidiformes. Donc lors de la primo-infection, il y a également atteinte de la muqueuse buccale et on parle d'un anthème. Donc il peut y avoir des érosions de 5 à 10 millimètres au niveau de la muqueuse buccale et de la muqueuse génitale ou anale.

Donc voici les lésions de la primo-infection. Donc un exanthème maculopapuleux, c'est pas spécifique, on le voit dans les infections virales de façon globale. Vous voyez ici donc un ananthème buccal avec ici des érosions au niveau de la muqueuse génitale.

Sur le plan biologique, donc, on trouve une lymphopénie à la numération formule sanguine, donc la lymphopénie on la trouve dans les exanthèmes viraux, un syndrome mononucléosique, une thrombopénie modérée et une cytorrhizée hépatique. Mais ce qui est spécifique, qui permet de confirmer le diagnostic de primo-infection VIH, c'est la positivité de l'antigénémie P24. En sérologie classique, elle est négative, l'ELISA à ce stade, et vous avez la charge virale.

Donc les deux éléments qui permettent de poser le diagnostic, c'est l'antigénémie P24 et la charge virale. Le diagnostic différentiel avec la syphilis secondaire, donc la première floraison de la syphilis, là où il y a la roseole syphilitique, on a un exanthème. La primo-infection, les autres virus qui peuvent donner, donc, un tableau pareil, l'Epstein-Barr virus, cet omégalovirus, HHV8, donc, herpès humain virus type 8, parvovirus B19, rubéole rouge, la rougeole, sans oublier que, donc, les manifestations cutanées du COVID-19 peuvent donner également un exanthème qui ressemble à ce qu'on voit dans la primo-infection VIH.

Bien sûr, il faut chercher ici, à ce moment-là, d'autres signes qui orientent vers le COVID, donc le contact avec des cas suspects ou des cas confirmés, l'existence du symptôme respiratoire, et donc, le contexte clinique. La fièvre boutonneuse méditerranéenne, l'exanthème médicamenteux, donc là, c'est un diagnostic différentiel également, il faut penser à ce diagnostic, surtout de voir la notion de prise médicamenteuse précédant l'apparition des lésions. Ptylisme rosé-giver, c'est une infection virale, dite herpès humain virus type 7, avec une sémiologie un petit peu particulière.

Vous avez une lésion arrondie, érythématospoïmeuse, de grande taille, qu'on appelle le médaillon, et puis, sept jours après, vous avez d'autres lésions, de petites tailles, disséminées au niveau du corps. Donc, l'évolution de la primo-infection, donc, on a une disparition des lésions cutanées et des autres signes de la primo-infection. Pendant 1-3 semaines, mais c'est pas une guérison de la maladie, hein, la maladie continuera à évoluer.

Donc, le risque, si on ne traite pas le malade au stade de primo-infection, c'est qu'il peut y avoir une lymphopénie marquée, et le malade, donc, peut développer des infections opportunistes. Si cette lymphopénie persiste, c'est un marqueur de mauvais pronostic. D'où l'intérêt de proposer un

traitement rapide, donc la trithérapie, à ce stade, pour diminuer, donc, la charge virale et améliorer le pronostic de la maladie.

Donc, la primo-infection, c'est une urgence diagnostique et thérapeutique. Donc, traitement symptomatique pour les manifestations générales, pour lutter contre la fièvre, traitement antirétroviral, c'est une urgence pour diminuer le taux de la charge virale résiduelle et éviter la progression de l'infection vers le sida. Donc, après la primo-infection, on va voir les autres manifestations cutanées de VIH.

Donc, on va voir la pathologie chimorale et on va parler de la maladie de Kaposi. Donc, la maladie de Kaposi se voit chez les CVA avec un taux de lymphocytes CD4 inférieur à 200 mm³. Donc, les premiers cas de maladie de Kaposi ont été décrits chez les homosexuels au San Francisco.

Sur le plan dermatologique, vous avez des plaques et des nodules rouges angiomateux. Dans la maladie de Kaposi sida, vous avez l'atteinte des muqueuses, la muqueuse mucale surtout, mais anogénitale également, c'est possible. Vous avez l'atteinte viscérale au niveau du type digestif.

Donc, on fait une exploration systématique dans le cadre de la maladie de Kaposi, une échographie abdominale, une fibroscopie, l'atteinte ganglionnaire, l'atteinte sourceuse et l'atteinte pulmonaire. Aussi, quelques images qui illustrent ces manifestations. Donc, ici, vous avez des papules et des nodules angiomateux.

Donc, là, chez ces patients, c'est généralisé au niveau du corps. Vous avez ici l'atteinte de la pointe du nez avec cette papule angiomateuse. L'atteinte de la muqueuse buccale, vous voyez ici, cette lésion nodulaire angiomateuse au niveau du gencive.

Là, l'atteinte au niveau du voile du palais. Là, l'atteinte pulmonaire. Il y a des diagnostics différentiels de la maladie de Kaposi.

Donc, il y a d'autres formes cliniques. Ce n'est pas la maladie de Kaposi associée à l'HIV. Il y a d'autres formes cliniques.

Il y a la forme européenne, dite également la forme méditerranéenne, qui se voit chez les sujets de sexe masculin. Les sujets âgés, 50-70 ans, donc, dans les pays méditerranéens, c'est la forme la plus fréquente au Maroc, avec des lésions cutanées localisées le plus souvent au niveau des membres inférieurs, avec un œdème. Il n'y a pas d'atteinte de muqueuse, pas d'atteinte viscérale.

Donc, ça, c'est un diagnostic différentiel. Et c'est la forme la plus fréquente dans notre pays. Vous avez la forme africaine.

Là, elle se voit plutôt chez l'enfant et l'adulte jeune, avec une atteinte cutanée ou muqueuse

extensive, atteinte ganglionnaire, viscérale et osseuse. Mais la sérologie VIH ici, elle est négative. Ce n'est pas une maladie de Kaposi VIH.

C'est la forme africaine. Vous avez la maladie de Kaposi qui se voit chez les sujets immunodéprimés. Donc, elle se voit sur un terrain immunodéprimé, surtout à cause du traitement par des immunosuppresseurs.

Par exemple, les greffés ou les patients qui présentent des maladies nécessitant un traitement immunosuppresseur, les maladies systémiques. Donc, ces malades peuvent développer des maladies de Kaposi, avec des lésions extracutanées possibles et également atteintes de la muqueuse glulaire. Le diagnostic de maladie de Kaposi est suspecté cliniquement, mais la confirmation, c'est l'histologie.

Il faut faire une biopsie de la lésion qui va vous montrer l'histologie. L'étude histologique va vous montrer une double prolifération vasculaire responsable de cet aspect, donc enjameur et fibroblastique. Donc, double prolifération vasculaire et fibroblastique.

L'étiologie, c'est l'herpès humain verrucipuis. Et dans la maladie de Kaposi, on fait une étude immunohistochimique et on détecte l'herpès. Donc, l'herpès humain verrucipuis dans la maladie de Kaposi.

Le traitement, vous avez l'interféron, la chimiothérapie, la radiothérapie, la chimiothérapie locale, la cryothérapie, parfois la chirurgie lorsqu'on est devant une lésion isolée. Donc, c'est possible. Après la maladie de Kaposi, toujours dans le cadre de la pathologie tumorale, vous avez les lymphomes.

Donc, c'est surtout les lymphomes ganglionnaires, type lymphome B ou la maladie d'Hodgkin, qui sont plus fréquents chez les CDN par rapport à la population normale. Également, on note une légère augmentation de la fréquence des lymphomes cutanés T épidermotropes, donc des lymphomes cutanés T chez les sujets VIH. Et on note également un taux important de carcinome épidermoïde chez ces patients, surtout au niveau de la muqueuse anal et génitale, donc à cause de l'infection par le papillomavirus humain.

Là, on voit des lymphomes ganglionnaires, lymphome de Burkitt et là, un carcinome épidermoïde au niveau de la muqueuse anal. Donc, après la pathologie tumorale, on va passer à la pathologie infectieuse et on va commencer par les infections virales. Le virus de l'herpès simple, simplex, est fréquent chez les sujets VIH.

On trouve cette infection chez 5 à 20 % des sujets VIH. La clinique est variable en fonction du stade de l'immunodépression. Donc, lorsqu'on a un taux de lymphocytes CD4 inférieur à 200 mm³, les lésions sont plus sévères, donc elles sont diffuses.

Leur évolution est chronique et on a des rechutes fréquentes. Donc, voici des images d'infections

herpétiques. Vous voyez donc des vésicules regroupées en beaucoup de fleurs, mais vous voyez que ce sont des lésions qui sont diffuses contrairement aux VIH qu'on voit chez les sujets immunocompétents.

Là également, vous voyez des lésions au niveau de la muqueuse génitale, des lésions étendues, inflammatoires et également une atteinte au niveau de la muqueuse anal. Le zona peut révéler la maladie, surtout chez les sujets jeunes. Il faut demander une sérologie VIH si vous avez un patient de moins de 50 ans qui développe des lésions de zona.

Donc, le zona, en général, il touche le territoire d'ADNR, donc il est métamérique. Chez le sujet VIH, il peut y avoir une atteinte plus diffuse, donc il ne respecte pas cette localisation qu'on voit chez les sujets immunocompétents. Le zona, normalement, c'est une maladie immunisante.

Les gens qui font du zona, c'est rarement qu'ils font notre poussée du zona, mais chez les sujets VIH, la récurrence est possible. Donc, la varicelle est plus rare que le zona, l'atteinte cutanée est profuse et il y a le risque d'atteinte pulmonaire et hépatique. Toujours dans le cadre des infections virales, on a le virus Epstein-Barr qui donne ce qu'on appelle la leucoplasie buccale de la langue.

Ça touche 50% des VIH au stade de sida maladie et il témoigne d'un marqueur d'évolutivité. Il témoigne d'une immunodépression sévère. Cliniquement, le patient présente des plaques blanchâtres légèrement verruqueuses disposées en fin réseau astri-parallèle vertical sur le bord latéral de la langue.

Comme vous voyez dans ces images, voici les lésions verruqueuses blanchâtres linéaires au niveau du bord de la langue. Là, l'aspect verruqueux est plus important. Toujours au niveau du bord latéral de la langue avec cette disposition linéaire.

Parallèles. Vous avez le papillomavirus humain que vous allez voir dans le cours sur les infections virales. Donc, vous avez les verrues, les condylomes.

Vous avez le molluscum contagiosum. Donc, le molluscum contagiosum, c'est une infection virale fréquente due au poxvirus. Elle est banale chez les enfants, mais lorsque vous voyez des lésions de molluscum contagiosum chez un sujet, donc c'est chez un adulte jeune ou un sujet âgé, il faut penser au VIH, il faut demander la sérologie.

Ça va 10 à 20 % des malades VIH positifs. Donc, elle est fréquente lorsque vous avez un taux de CD4 inférieur à 100. Et là, on est en général devant des lésions diffuses.

Vous avez cet oméga virus qui peut donner deux types de lésions. Vous avez dans le cadre de l'éruption maculopapuleuse généralisée, dans le cadre de la primo-infection. Et ça ressemble à la primo-infection VIH, éruption diagnostique différentielle, ou bien ça peut donner des ulcérations péri-anales, des ulcérations chroniques.

Donc, chez un sujet VIH, si vous trouvez des ulcérations périannales, il faut penser au cytomegalovirus, il faut penser à l'hépatite, il faut penser à la pathologie tumorale, car sinon, épidermoïdes. Là, c'est des lésions de végétation vénérienne. Là, c'est des lésions de molluscum contagiosum avec ces lésions des papules ombiliquées, perlées et ombiliquées au centre.

Voici des lésions de molluscum contagiosum. Après les infections virales, on passe aux infections fongiques. Et vous avez surtout les candidoses.

Ceux-ci se voient dans 81% des cas de SIDA. Il y a une atteinte de la muqueuse buccale, mais également il y a l'extension des lésions au niveau du pharynx et au niveau de l'échevage. Vous avez un aspect, donc, pseudomembraneux en général, le muguet buccal avec des onguits blanchâtres.

Vous avez l'aspect atrophique, hyperplasique et l'aspect noir villosité. On trouve également une perlèche, donc, cette fessure au niveau de la commissure labiale et ces lésions, donc, cette candidose, et les chroniques récidivantes, parfois résistance au traitement classique. Aspect de muguet buccal et une perlèche.

Vous avez également les dermatophytes, avec surtout l'atteinte des ongles, les zones onychomycoses. Et on a l'onychomycose profonde, donc, l'ecryptococcus glistoplasmos, avec 10% des cas de localisation cutanée. Il peut y avoir ces mycoses profondes, elles donnent une atteinte viscérale sous-jacente, une atteinte pulmonaire, hépatique et cérébrale.

Sur le plan cutané, les lésions se présentent sous forme de papules qui ressemblent au molluscum contagiosum, donc, des papules pseudo-molluscum contagiosum, en général. Et là, devant des papules chez un sujet qui présente, donc, une sérologie positive, sujet, donc, VIH positive, on fait des biopsies cutanées avec des études anatomopathologiques et une étude mycologique. Donc, voici des lésions de dermatophytose.

L'aspect de dermatophytose, d'herpès circonscrit. Mais là, vous voyez, chez le sujet VIH, cet aspect un petit peu inflammatoire, contrairement au sujet normal, où, en général, on trouve des lésions d'herpès circonscrit avec une tendance à la guérison centrale. Vous avez l'atteinte, les onychomycoses, et là, un aspect d'intertrigo associé.

Une mycose profonde, avec des papules qui ressemblent au molluscum contagiosum. Vous voyez les papules. Donc, ici, c'est l'histoplasmosse et la cryptococcose.

Donc, après les infections virales mycologiques, vous avez les infections bactériennes. Donc, c'est surtout le staphylococque avec les folliculites, le staphylococcus aureus, avec des folliculites, donc, des lésions banales, le streptococque, avec, donc, l'impétiginisation des lésions, l'impetigo. La tuberculose cutanée, c'est pas fréquente, contrairement à la tuberculose pulmonaire.

Vous avez l'angiomatose vacillaire, qui est, donc, des lésions qui ressemblent à la maladie de Kaposi. C'est des papulonodules angiomatoïdes. C'est le principal diagnostic différentiel de la maladie de Kaposi.

Et vous avez le risque des maladies sexuellement transmissibles associées, donc, les urétrites, la syphilis, mais, le chancre d'encre, les autres IST. Il faut, bien sûr, dépister. Donc, là, vous voyez les pustules centrées par des poils, donc, c'est des folliculites, donc, staphylococciques.

Là, vous avez une lésion londulaire d'une gomme, fistulisée au niveau de la peau, c'est la tuberculose cutanée. Là, l'angiomatose vacillitaire, avec des papulonodules angiomatoïdes, à teinte d'effuse, visage tronc. Vous voyez, ça ressemble à la maladie de Kaposi avec la teinte de la muqueuse buccale.

Et là, c'est l'anapathie, la biopsie, avec études histologiques et études bactériologiques. Il faut confirmer le diagnostic. Les infections parasitaires, vous avez la gale, soit la forme classique, avec la teinte de prurites nocturnes, la teinte des espaces interdigitaux, la teinte des organes génitaux.

Et il y a une forme qui s'appelle la gale norvégienne, qui se voit chez les sujets tarés, immunodéprimés, donc au stade de maladie avec une immunodépression sévère. Ça donne des lésions, parfois généralisées, électrodermiques, hyperkeratosiques. Et là, le prurite, il est absent, mais les lésions sont très contagieuses.

Et puis, vous avez les dermatoses non infectieuses, d'antimorales qu'on voit de façon... donc fréquente chez les sujets VIH. Vous avez la dermite séborique. Donc, ça donne des lésions, donc, erythematoscoïmeuse au niveau du cuir chevelu, au niveau de la lisière du cuir chevelu, au niveau du sillon nasogénien, au niveau du thorax.

Vous avez la xérose, donc cette sécheresse cutanée. Vous avez le psoriasis. Rappelez-vous que le psoriasis peut être, donc, déclenché ou aggravé par les infections, le streptococque chez les enfants et le VIH chez l'adulte.

Donc, si vous avez une poussée de psoriasis que vous n'arrivez pas à expliquer, il faut demander une sérologie VIH après accord de votre patient. La mélanodermie, donc un aspect de pigmentation au niveau de la peau, pigmentation diffuse. Les aphtoses, l'hypertrichose biliaire, surtout au niveau des sourcils, parfois au niveau des cils, vous avez ces poils qui sont augmentés de façon impressionnante.

Ce n'est pas la physiopathologie. Vous avez la porphyrite cutanée tardive. C'est une phrotodermatose.

Donc, vous avez des bulles, après exposition solaire, des bulles au niveau de la face dorsale des mains et une hypertrichose malaire. Et vous avez les toxédermies médicamenteuses avec les

différents tableaux cliniques de ces toxérmies médicamenteuses. Le VIH, c'est parmi, donc, des facteurs, des risques de développer des toxérmies médicamenteuses, surtout que ce sont des patients polymédicamenteux.

À côté de la trithérapie pour le VIH, il y a des antibiotiques dans le cadre de la prévention de certaines infections et parfois, donc, des antibacillaires en cas de tuberculose. Donc, ce sont des candidats à, des candidats à développer des toxérmies médicamenteuses parce que ce sont des malades polymédicamenteux. Aussi, l'aspect de la dermite ciborique, les zones érythématosco-hameuses, au niveau des zones angéliques, donc, au niveau du moustache.

Là, c'est un psoriasis avec un tas d'ingoyales. Là, c'est un tableau de toxérmie médicamenteuse, un exantème. Il faut demander la sérologie VIH dans les situations suivantes.

Exantème de la primo-infection. On ne va pas demander une sérologie VIH devant tout patient qui présente un exantème, c'est-à-dire un rash maculopapuleux. C'est lorsque vous suspectez une primo-infection VIH, c'est-à-dire l'interrogatoire ici est important.

Est-ce qu'il y a une notion d'exposition? Est-ce qu'il y a un rapport sexuel non protégé qui a précédé cet exantème? Est-ce que c'est un terrain à risque? Est-ce que c'est un patient qui se drogue? Donc, tous ces éléments sont importants à rechercher avant de demander cette sérologie. Dermis séboréique d'apparition récente, floride et résistant au traitement. La même chose pour le psoriasis.

D'apparition récente, floride et résistant au traitement. L'apport férocutané tardif. Maladie sexuellement transmissible.

Tous les patients qui présentent une maladie sexuellement transmissible peuvent donc attraper les autres maladies sexuellement transmissibles. Donc, logiquement, on cherche, on fait tous les bilans des IST. Zone de l'adulte jeune, moins de 50 ans.

Candidose, dermatophysie, floride et ou multirécidivantes. Et la maladie de Kaposi. Donc, pour conclure, les manifestations cutanées de VIH sont fréquentes pour les morts, parfois révélatrices de la maladie.

Elles ont un marqueur pronostic. Leur incidence et leur sévérité dépendent du stade de l'immunodépression. Le rôle de médecin est capital dans la prévention.

La prévention primaire avant l'apparition de ces maladies sexuellement transmissibles par l'éducation, la sensibilisation et l'information. La prévention secondaire par l'instauration d'un traitement rapide vers le diagnostic de primo-infection de façon rapide, instaurer un traitement de façon rapide, ça permet d'éviter l'évolution donc rapide vers le stade de sida maladie. Et également donc la prévention secondaire des autres infections opportunistes.